Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
21ª Vara Cível - Seção A da Comarca do Recife

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800

Processo nº 0097870-76.2021.8.17.2001

AUTOR: FRANCISCA GONCALVES ARAGAO DA CUNHA LIMA

REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos etc.

FRANCISCA GONCALVES ARAGAO DA CUNHA LIMA, já qualificada, através de advogado devidamente habilitado, propôs a presente ação sob o procedimento comum, em face da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, também qualificada.

Alega a autora que há dois anos foi diagnosticada com CÂNCER NO ENDOMÉTRIO, ocasião em que realizou cirurgia para a retirada do útero, bem como tratamento de radioterapia e quimioterapia.

Afirma a demandante que este ano (2021) realizou exame de PET TC, somente autorizado mediante ordem judicial (processo nº 0062554-02.2021.8.17.2001), tendo em vista a negativa pelo plano de saúde réu, e foi constatada a recidiva da doença, bem como a existência de novos pontos de metástase, além do aumento de lesões pulmonares e hepáticas.

Diante desse quadro, as médicas oncologistas assistentes da autora, Dra. Jurema Telles, CRM nº 11279-PE e Dra. Daniela de Freitas (CRM 104298) indicaram o tratamento medicamentoso com PEMBROLIZUMABE, cujo nome comercial é KEYTRUDA, associado com LEVATINIBE (LENVIMA), no entanto, a autora teve a cobertura negada expressamente pelo plano de saúde demandado, ante a justificativa de ausência de cobertura contratual.

Assevera a demandante que diante da urgência do início do tratamento ante a gravidade da doença e o risco de morte, precisou custear o primeiro ciclo do tratamento, no importe de R$ 47.256,27 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Face o exposto, requereu a autora, inicialmente, a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que a operadora de plano de saúde demandada autorizasse e custasse integralmente as despesas relacionadas ao seu tratamento oncológico, em conformidade com a prescrição médica, através dos fármacos PEMBROLIZUMABE, cujo nome comercial é KEYTRUDA, associado ao medicamento LEVATINIBE (LENVIMA), sob pena de multa diária.

Ao final, requereu a confirmação da tutela provisória de urgência, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do ressarcimento da primeira dose do tratamento oncológico, no importe de R$ 47.256,27 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), acrescido das correções legais.

Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente (Id. Num. 91028388).

As partes participaram de audiência de conciliação, nos termos do art.334 do CPC, no entanto, não chegaram a um acordo (Id. Num. 95118386).

A demandada CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou contestação (Id. Num. 96629620) em que afirma que a negativa do medicamento 'Keytruda' sob o argumento de que o tipo de câncer que acomete a demandante não se encontra na indicação da bula do aludido remédio. Em relação ao outro medicamento, 'Lenvatinibe', afirma a ré que negou a cobertura em razão do quadro clínico da Autora não preencher os critérios estabelecidos para abono, conforme estabelecido pelas Diretrizes de Utilização da RN 465/2021 da ANS.

Réplica (Id. Num.104789060).

Despacho determinando a intimação das partes para informar interesse na produção de novas provas (Id. Num. 105151605).

Ambas as partes declaram-se satisfeitas em relação às provas até então produzidas e requereram o julgamento antecipado da lide (Id. Num. 106406414 e 106506691).

Vieram-me conclusos.

DECIDO.

O feito apresenta-se suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC, por não haver necessidade de dilação probatória.

À partida, cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros. Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os* administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual, ressaltando-se que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde do contratante.

A controvérsia ora posta cinge-se a determinar se a negativa de cobertura perpetrada pela operadora de plano de saúde demandada foi efetuada de forma ilícita, bem como se houve dano moral decorrente da resistência ao custeio do tratamento de câncer prescrito pelas médicas assistentes da autora.

Conforme laudos emitidos pelas médicas oncologistas Dra. Daniela de Freitas (CRM 104298) e Dra. Jurema Telles De Oliveira Lima (CRM 11279), juntados aos autos sob os Id´s Num. 90913784 e 90913785, respectivamente, o tratamento associado das duas medicações (PEMBROLIZUMABE e LEVATINIBE) mostra-se adequado e necessário para o quadro da autora ante a gravidade e agressividade e recidiva da doença, devidamente constatado no exame de PET-CT (Id. Num. 90947231).

No entanto, a autora teve negada cobertura tanto do tratamento com a medicação KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE)(Id. Num. 90917995), quanto do LEVATINIBE (id. nº 90917997), sob o argumento de ausência de cobertura contratual.

Pois bem. Cumpre esclarecer que não se mostra razoável a recusa do tratamento oncológico efetuada pela seguradora ré, com base, exclusivamente, em cláusula limitativa da cobertura pleiteada.

Com efeito, embora o plano de saúde possa excluir da cobertura contratual determinadas doenças, não pode limitar os procedimentos e os insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura.

A negativa em fornecer medicação devidamente prescrita, sob o argumento de cláusula limitativa da cobertura não pode prosperar, tendo em vista que viola os princípios da boa-fé objetiva e da própria função social, colocando o paciente em desvantagem, retirando dele a chance de sobrevida digna.

Sobre o fornecimento de medicamento pelas operadoras de plano de saúde, o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento de Recurso Especial Repetitivo (tema 990), assim decidiu:

> [...] Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. [...] 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente. A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. [...] (REsp 1712163 SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

No caso em questão, a parte autora comprova que a medicação prescrita encontra-se registrada na ANVISA, conforme consultas anexadas em sua petição inicial (Id. Num. 90912497 - Pág. 10), o que corrobora o desacerto na negativa perpetrada pela ré.

Também não se sustenta a alegação da ré de acerto na negativa de fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE "Keytruda" pelo fato de não constar na bula a indicação de tratamento de câncer no endométrio, pois, consoante bula do aludido medicamento acostado aos autos sob o Id. Num. 90918017 - Pág. 3, existe clara indicação para tratamento de câncer de endométrio, conforme item 1.16.

No que tange à negativa de cobertura do medicamento LEVATINIBE, a demandada defende que quadro clínico da Autora não preenche os critérios estabelecidos para abono, conforme estabelecido pelas Diretrizes de Utilização da RN 465/2021 da ANS.

Conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde foi juntado aos autos sob o Id. Num. 96629627-Pág-5, observa-se que o medicamento LEVANTINIBE encontra-se no rol, item 64, como uma das substâncias de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer.

Importante ressaltar que o presente caso não se coaduna com os parâmetros estabelecidos no julgamento recente realizado pela 2º Seção do Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704, que entendeu, dentre outros termos, que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seria, em regra, taxativo. Pois, a medicação prescrita encontra-se no rol da ANS.

A questão aqui é outra, o plano de saúde demandado nega a cobertura do tratamento antineoplásico por não constar no rol a indicação da medicação para a especificidade do câncer que acomete a demandante.

Vale ressaltar que, em nenhum momento, a operadora do plano de saúde alegou que a doença diagnosticada na autora não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes.

Neste contexto, não lhe incumbe limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao médico que assiste à paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento para tratamento de câncer simples motivo de não está indicado para o tipo de câncer da qual é portadora a demandante.

Nesse sentido:

> EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 08013434120178140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020).

RECURSO INOMINADO. PLANO E SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. LENTE INTRAOCULAR IMPORTADA - CATARATAS. INOVAÇÃO RECURSAL – ART. 12, I, B, LEI DOS PLANOS DE SAÚDE E RESOLUÇÃO Nº 211/2010 DA ANS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE DECIDIR QUAL O PROCEDIMENTO MÉDICO MAIS ADEQUADO AO CASO. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001956-55.2019.8.16.0134 - Pinhão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 25.08.2020). (TJ-PR - RI: 00019565520198160134 Pinhão 0001956-55.2019.8.16.0134 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 25/08/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/09/2020)

Trata-se, pois, de conduta abusiva a prática consistente na exclusão de cobertura de exames e procedimentos que visem o restabelecimento da saúde do segurado, o que notadamente é o caso dos presentes autos.

Assim, diante dos elementos de prova carreados, entendo que a postura do réu na vertente hipótese se afastou da boa-fé objetiva, descumpriu a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e frustrou a legítima expectativa do paciente em ver-se protegido pelo plano de saúde contratado.

Ressalte-se que a Jurisprudência Pátria vem se manifestando no sentido de ser obrigatória a cobertura de exames, tratamentos e procedimentos para tratamento de câncer pelos planos de saúde, conforme se pode extrair dos arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenizatória. Plano de saúde de Autogestão. Negativa de autorização. Medicamento "LENVIMA 12MG". Tratamento para carcinoma hepatocelular e cirrose hepática child. 1. Pretensão formulada pelo autor pleiteando o fornecimento de medicamento, diante de quadro de grave moléstia e indenização por danos morais e materiais, diante da falha na prestação do serviço. 2. Irresignação da ré em face de sentença que confirmou a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente para o tratamento de saúde do autor com a condenação ao

pagamento de indenizações a título de danos materiais e danos morais. 3. Não incidência do CDC na hipótese, por se tratar de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula nº 608, STJ). 4. Ré que não produziu qualquer prova hábil nos autos, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito assegurado ao autor (art. 373, II do CPC). 5. Precedente do STJ, reconhecendo a abusividade da recursa de fornecimento de medicamento não constante no rol da ANS pelas operadoras de plano de saúde, ainda que de autogestão (AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 6. Incidência das Súmulas 338 e 211 do TJRJ. 7. Dano moral configurado. Valor indenizatório arbitrado a este título que se mostra excessivo, comportando redução, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Retificação da sentença de ofício. Dano material e danos morais. Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00410803820208190001, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 25/05/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2021)".

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) - TRATAMENTO "OFF -LABEL"INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). Precedentes do STJ. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade. (TJ-MT 00011965620208110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

Portanto, revela-se injusta a negativa de cobertura perpetrada pelo plano de saúde, prosperando tanto o pleito alusivo à obrigação de fazer da demandada de custear o tratamento indicado pelo médico assistente da autora,

quanto o ressarcimento do valor pago pelo primeiro ciclo de tratamento, no valor de R$ 47.256,27 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), consoante nota fiscal de Id. Num. 90918001 - Pág. 1, acrescida das correções legais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este também é procedente. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento, etc[1] (file:///C:/Users/SU%C3%8ANYA/Desktop/21%20VARA%20C%C3%8DVEL%20A/SENTEN%C09.2021.8.17.2001%20.%20senten%C3%A7a.%20plano%20de%20sa%C3%BAde.%20medic[1].

A conduta da ré ultrapassou o mero descumprimento de dever contratual, na medida em que, ao recusar a realização de procedimentos indicados por médicos conveniados, inviabilizou o pleno exercício do direito à saúde do consumidor, lesando sua dignidade, restando caracterizado o dano de natureza extrapatrimonial

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> STJ-0451560 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO) E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. 1. **A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa.** Precedentes. 2. O óbice insculpido na Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com amparo na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos reclamos fundados na alínea "a", uma vez que a expressão "divergência", referida no citado verbete sumular, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional. 3.

Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 430.208/CE (2013/0376246-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 20.03.2014, unânime, DJe 09.04.2014).

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si e a extensão do dano sofrido, nos termos do art. 944 do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Esclareço que, nos termos do art. 292, inciso V, do CPC/15, a parte autora deve quantificar sua pretensão indenizatória a título de danos morais, que deve ser considerada para o arbitramento do valor da causa.

Apesar da necessidade de estipulação da quantia almejada, continua válido o enunciado da Súmula nº 326, do STJ, o qual estabelece que "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Isso porque o bem da vida pretendido pela parte, na hipótese, é o reconhecimento do dano suportado em decorrência de ato ilícito praticado pela parte adversa e o recebimento da respectiva indenização.

O arbitramento do *quantum* indenizatório compete exclusivamente ao julgador, diante da análise dos elementos do caso concreto, não podendo o juiz ficar adstrito à quantia indicada pela parte na petição inicial, na medida em que a extensão do dano apenas pode ser apurada em cotejo ao acervo probatório constante dos autos. Assim, o acolhimento do pleito indenizatório configura integral procedência do pedido, ainda que o valor estipulado seja inferior ou superior ao indicado pela parte autora na inicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 47.256,27 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), consoante nota fiscal de Id. Num. 90918001 - Pág. 1, a ser atualizada pela tabela do ENCOGE, desde a data do desembolso, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo adimplemento.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta a ser corrigida monetariamente pela tabela ENCOGE, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

c) JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação da ré na obrigação de autorizar e custear o fornecimento dos medicamentos PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) e LEVATINIBE, pelo período, forma e na dosagem que se fizer necessária, tudo conforme laudos médicos de id. 90913784 e 90913785 e respectivas solicitações de id´s 90948334 e 90948337, **confirmando o teor da decisão interlocutória de Id. Num. 91028388.**

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife (PE), 16 de junho de 2022.

Nehemias de Moura Tenório

Juiz de Direito

[1] (file:///C:/Users/SU%C3%8ANYA/Desktop/21%20VARA%20C%C3%8DVEL%20A/SENTEN%C3%87AS/PLANOS%20DE
09.2021.8.17.2001%20.%20senten%C3%A7a.%20plano%20de%20sa%C3%BAde.%20medica%C3%A7%C3%A3o%2

[1] STJ, 4ª Turma, REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015.

Assinado eletronicamente por: NEHEMIAS DE MOURA TENORIO
16/06/2022 17:13:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 108150442

22061617134965000000105753602

IMPRIMIR GERAR PDF